Dolor torácico, síncope y lipotimia

SEMIOLOGIA · Clase 18 · qué duele, por qué, y por qué se cae el paciente

1 · LA ANAMNESIS MANDA Y EL DOLOR ISQUÉMICO NACE EN EL MIOCARDIO

Anamnesis cardiovascular F1
aporta hasta el 50 % del diagnóstico; el examen físico, un 30 %

en la angina llega al extremo:

En la angina de pecho F1
el diagnóstico puede lograrse en 100 % solo con el interrogatorio

Aterosclerosis coronaria
explica el 90 % de los casos

Émbolo o vasoespasmo
menos frecuentes; el vasoespasmo a veces por cocaína

con menos frecuencia produce el

en 90 % produce el

Desequilibrio de oxígeno
la oferta coronaria es menor que el consumo del miocardio

por hipoxia celular produce el

Dolor isquémico
retroesternal, opresivo, por hipoxia celular del músculo

2 · LOS ATRIBUTOS DEL DOLOR: DÓNDE, CUÁNTO DURA Y QUÉ LO CALMA

Atributos del dolor
localización, carácter, irradiación, duración, intensidad, desencadenantes, atenuantes y concomitantes

según la intensidad varía la

Irradiación
proporcional a la intensidad: cuello, mandíbula, brazo izquierdo o epigastrio

cuánto dura

Duración
angina estable 2-10 min · inestable hasta 20 min · infarto más de 20 m

qué lo provoca

Desencadenantes
angina: esfuerzo, frío, estrés, c… copiosa · infarto: reposo nocturno

qué lo alivia

Atenuantes
reposo o nitratos alivian la angina; el infarto no cede con ninguno

los concomitantes pueden faltar en el

Infarto silencioso
ancianos y diabéticos pueden tener solo náuseas, sudor frío o disnea

cuanto más lejos, más apoya el

si dura 2-10 min

si supera 20 min

si aparece en reposo nocturno

si lo pro… si no cede con ninguno… nitrato

aun sin dolor orienta al

3 · ANGINA O INFARTO, Y ANTE LA DUDA ECG PRIMERO

Angina
opresiva, 2-10 min, por esfuerzo; cede con reposo o nitrato

…ia por duración y alivio del

Infarto
más de 20 min, en reposo, con sudoración fría; no cede porque ya hay necrosis

ante la duda se aplica el

Dolor dudoso
ECG y enzimas antes de cualquier analgésico

si se invierte el orden hay

Analgesia a ciegas
puede ocultar un infarto mientr… la regla se cumple con necrosis continúa

por eso la regla es

El patrón orienta; el ECG y las enzimas confirman

por el patrón típico de la

se caracteriza con los

se separa por la palpación de la

se separa por el ECG normal del

tampoco se analgesia antes del

a diferencia de la

4 · LOS DOLORES QUE NO SON ANGINA

Disección aórtica
lancinante y súbito, entre las escápulas; ECG normal

Dolor pericárdico F2
las hojas inflamadas se rozan: empeora con respiración, deglución y decúbito dorsal; alivia inclinado hacia adelante

se separa por postura, no esfuerzo

Horas a días, sin relación con el esfuerzo: se separa de la angina por la postura

como los otros, se reconoce por su

Dolor psicógeno F3
en la punta (mamilar), sordo, horas a semanas; cede con ejercicio, ansiolíticos o placebo

se separa porque el esfuerzo lo calma

Al revés que la angina: el esfuerzo lo calma

como los otros, se reconoce por su

Dolor condrocostal
punzante, se reproduce al palpar las articulaciones

también se reconoce por su

Cada dolor se reconoce por su historia, no por su localización sola

a diferencia de la

a diferencia de la

5 · SÍNCOPE O LIPOTIMIA: UN CEREBRO SIN SANGRE

Flujo cerebral
recibe el 20 % del débito, unos 55 ml/100 g

si cae por debajo del

Umbral de síncope
flujo bajo 30 ml/100 g/min o PAM menor de 30 mmHg

alcanzado, produce el

Asistolia
más de 5 s de pie basta para el síncope

de pie, también produce el

Síncope
pérdida súbita y transitoria de conciencia y tono por caída del flujo cerebral

si se prolonga lleva a la

Isquemia sostenida
más de 5-10 min causa muerte neuronal irreversible

a diferencia de la

Lipotimia F4
sensación inminente de desmayo, sin perder la conciencia; comparte las causas del síncope

fuera de la numeración queda la

marca la gravedad en el

7 · LO QUE QUEDA FUERA DE LOS CINCO

Hipoglucemia F5
diabético tratado o ayuno prolongado: el cerebro sin glucosa se apaga igual

Otras causas menos frecuentes
ACV, hiperventilación con alcalosis respiratoria y síncope histérico

fuera de la numeración quedan

también orienta el

también orientan el

Mecanismo, pródromo y postura orientan el tipo de síncope

6 · LOS CINCO MECANISMOS DEL SÍNCOPE

Cinco mecanismos
1 cardiogénico · 2 vasovagal · 3 tos, micción o defecación · 4 ortostático · 5 seno carotídeo

1 · si cae el débito cardíaco

2 · si predomina el vago

3 · si sube la presión intratorácica

4 · si cae la PA al ponerse de pie

5 · si se estimula el seno

1 · Cardiogénico
baja el débito: arritmias, estenosis aórtica o mitral, infarto; en ancianos

2 · Vasovagal
sube el tono vagal: vasodilatación ± bradicardia; joven de pie, con náusea y sudor

3 · Situacional
tos, micción o defecación suben la presión intratorácica y baja el retorno venoso

4 · Ortostático
caída de PAS ≥ 20 o PAD ≥ 10 mmHg a los 3 min de pie

5 · Seno carotídeo
al girar la cabeza o apretar el cuello bajan PA y FC

si hay bloqueo AV grave da el

se revierte con la

Stokes-Adams
bloqueo AV grave con convulsiones y relajación de esfínteres

Recuperación vasovagal
acostado y con las piernas elevadas vuelve la sangre al cerebro

su causa se ordena en

comparte las causas de los

la situación orienta el

la postura orienta el

el giro de cabeza orienta el

sus convulsiones orientan el

su rápida respuesta confirma el

técnica · concepto · causa · mecanismo · síntoma · diagnóstico · complicación · desenlace · signo · síndrome · ejemplo · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor, Semiología General — 08a Anamnesis y síntomas cardiovasculares, 08a2 Síntomas viscerales — teoría del docente